

INDICADO POR: Dr. Felipe Fortes	
X ACOMPANHAMENTO () CONSULTA	
NS	
MARCIO ALVES SILVEIRA	
IDADE: 46	PESO: 89 ALTURA: 175
PROFISSÃO: comerciante	
SINTOMAS: esquecimento	
* Dorne D.L	
QUEIXAS: Dorco	
MEDICAMENTOS: faz uso hormonalizante	
MÉDICO: Dr. Felipe Fortes	
MARCAPASSO: () S () N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N	
EXERCÍCIO FÍSICO: 4x musc / 2x pedal	
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: S (21:30)	
HORA QUE DORME: 00:00	
HORA QUE ACORDA: 8h	
COCHILHO () S (X) N	
DORME ACOMPANHADO: () S (X) N () EVENTUALMENTE	
TEM FILHOS: (X) S () N 11a DORMEM NO QUARTO: () S (X) N	
PET NO QUARTO: () S () N	
BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA (X) N sim FS.	
FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:	
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal	
BANHEIRO/NOITE: 0x	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal	
CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP: não	
MALLAMPATI:	
IAH: 31,4	
SPO2: 80% basal 92%	
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: rinite / sinusite	
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA elas são 4.	
HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: —	
COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA	
(N) ORTOPÉDICA	
(S) NEUROLÓGICA	
() OUTROS:	
POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N	
SPO2 C/ CPAP: —	
PRESSÃO NO EXAME: —	
1202 Avaliação	
25	

Dr. Marco Alves Ferreira

Exame para avaliação

de adaptação de CPAP a Sr. Marcia

devido a SAOS de

grau moderado.

(CID: G47.3)

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA BASAL

Nome: MARCIO ALVES FERREIRA

Sexo: Masculino

Data do Exame: 24-08-2025

Idade: 45 anos

Peso: 88 kg

Altura: 1,76 m

Médico Solicitante: DR. SHANDI PRILL

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 24/08/2025 22:15 e finalizado às 25/08/2025 05:46.

A latência para início do sono foi de **8,0** min e a latência para o sono REM de **131,0** min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 371,0 min, com eficiência do sono de **82,4** %.

A distribuição dos estágios do sono mostrou **3,4** % de estágio N1, **81,8** % de estágio N2, **3,8** % de estágio N3 e **11,1** % de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 71,0 min. Ocorreram 219 despertares, sendo o índice de **29,2 (nº/h)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **0,0 (nº/h)**, 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 194, sendo 0 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 194 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **31,4 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 16,1 e o IDR durante o sono NREM foi de 33,3. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de **31,4 (nº/h)**, sendo 0,0 apneia/h e 31,4 hipopneia/h.

A **saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂)** basal foi 92%, a **média** de 91% e a **mínima** de **80%**.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (**IDO**) foi de 30,0 (nº/h), sendo que em REM foi de 17,6 (nº/h) e em NREM foi de 38,2 (nº/h). Permaneceu **16,7** % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de **90%**.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (5), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório (**31,4 n°/h**) (VN= até 5 n°/h);
2. Saturação mínima da oxi-hemoglobina (**80%**);
3. Latência para o início do sono (**8,0 min**) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM (**131,0 min**) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono (**82,4 %**) (VN= $\geq 85\%$);
6. Índice de despertares **29,2 n°/h** (VN= até 15 n°/h);
7. Percentual do estágio N1 (**3,4 %**) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 (**81,8 %**) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta (**3,8 %**) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM (**11,1 %**) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

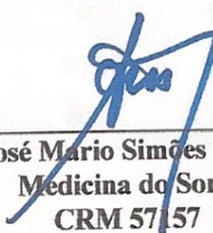
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

DADOS DO PACIENTE:

Nome: MARCIO ALVES FERREIRA
ID: 0
Altura: 1,76 m
Peso: 88 kg
Sexo: Masculino
Data de Nascimento: 26-10-1979
IMC: 28,41

DADOS DO EXAME:

Hora do Exame: 22:15:59
Data do Exame: 24-08-2025
Médico Solicitante: DR. SHANDI PRILL

Análise do Sono	
Data/Horário de Início:	24/08/2025 22:15
Data/Horário de Término:	25/08/2025 05:46
Tempo Total de Registro (TTR):	450,0
Tempo Total de Sono (TTS):	371,0
Latência para o início do sono:	8,0
Latência para o sono REM:	131,0
Tempo acordado após o adormecer:	71,0
Eficiência do Sono (TTS/TTR x 100):	82,4 %

Estágios do Sono					
	N1	N2	N3	REM	Vigília
Minutos	12,5	303,5	14,0	41,0	79,0
% de TTS	3,4	81,8	3,8	11,1	17,6

Despertares			
		Número	Índice (nº/h)
Total despertares	de	219	29,2

Frequência Cardíaca		
	Média [bpm]	Máx [bpm]
REM	66,3	94
NREM	68,2	214
Vigília	76,0	99

Apneias/Hipopneias/RERAs								
	Apneias			Apneias (A)	Hipopneias (H)	A + H	"RERA"	A + H + "RERA"
	Central	Obstrutiva	Mista					
Número	0	0	0	0	194	194	0	194
Índice	0,0	0,0	0,0	0,0	31,4	31,4	0,0	31,4
Índice em REM	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	16,1	0,0	16,1
Índice em NREM	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	33,3	0,0	33,3
Duração máx (seg)	0	0	0	0	53,7	53,7	0	53,7
Duração média (seg)	0	0	0	0,0	24,9	24,9	0	24,9
Índice em Supino	0	0	0	0	0	0	0	0
Índice em Não Supino	0,0	0,0	0,0	0,0	33,1	33,1	0,0	33,1

- Apneia = queda de 90% do fluxo medido pelo termistor, com duração ≥ 10 segundos;

- Hipopneia = queda de 30% do fluxo medido pela cânula de pressão associada à dessaturação de 3% e/ou associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos;

- RERA (Respiratory effort related arousals) = achatamento da curva de fluxo aéreo indicado pela cânula de pressão associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos.

Índice de apneia + hipopneia: 31,4 (nº/h)

Índice de distúrbio respiratório (IDR = Apneia + Hipopneia + "RERA"): 31,4 (nº/h)